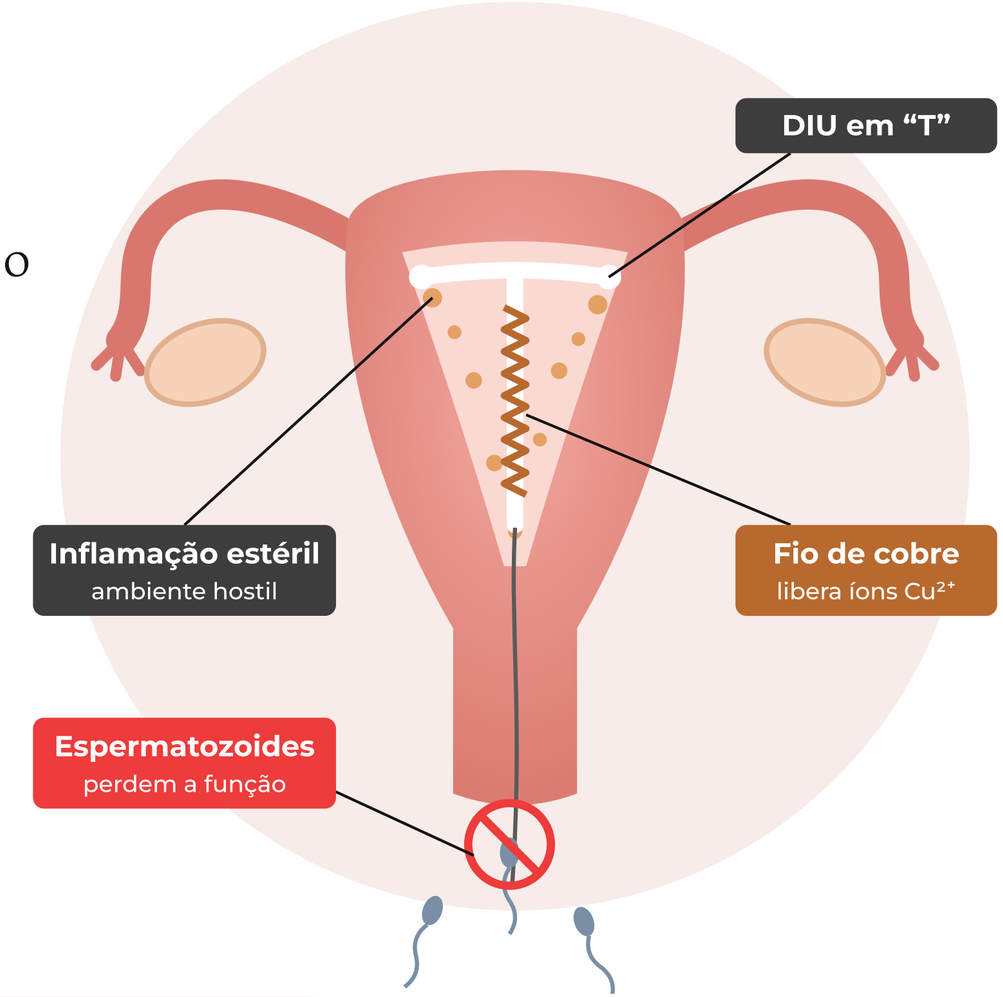
DIU de Cobre como Contracepção de Emergência

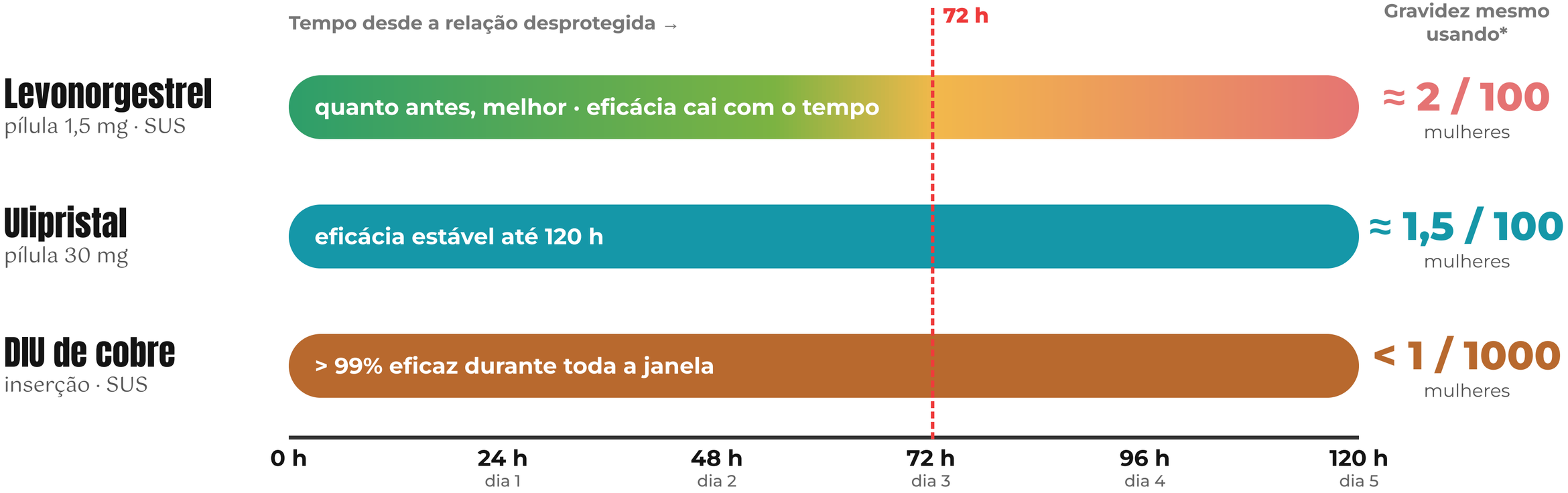
- O que é: pequeno “T” de plástico envolto por fio de cobre (TCu 380A), disponível no SUS.
- Mecanismo: o cobre gera uma reação inflamatória estéril no útero, tóxica para espermatozoides e óvulo → **impede a fecundação**.
- Janela: inserção até **5 dias (120 h)** após a relação desprotegida.
- Eficácia: > 99% — **é a CE mais eficaz que existe**.



Não sofre efeito do IMC | **Sem interação com remédios** | **Protege por até 10 anos**

Fonte: OMS (2021); FEBRASGO – Manual de Anticoncepção; Cleland et al., Hum Reprod (2012).

A “Régua das 120 horas”



Exemplo prático: a camisinha rompeu no **sábado às 22h**. Levonorgestrel: tomar o quanto antes (ideal até **terça 22h**). DIU de cobre ou ulipristal: ainda funcionam até **quinta-feira 22h**.

*Taxas aproximadas. Glasier et al., Lancet (2010); Cleland et al., Hum Reprod (2012); OMS (2021).

Na prática: qual CE escolher?

Relação desprotegida / falha do método
há até 5 dias (120 h)

Quer um método de longa duração e **não tem contraindicação** ao DIU?

SIM → **DIU de cobre**
1ª escolha · > 99%
já fica como método

NÃO

Então, pílula: **há quanto tempo** foi a relação?

até 72 h
Levonorgestrel 1,5 mg
dose única (SUS)

72 - 120 h
Ulipristal 30 mg*
ou LNG o quanto antes

Caso: Júlia, 24 anos

Camisinha rompeu há **4 dias**. IMC = 32. Diz: *"queria algo pra não me preocupar mais"*.

→ Melhor opção: DIU de cobre

Está no 4º dia (fora do ideal do LNG), IMC alto reduz o LNG e ela quer método contínuo.

IMC ≥ 30: o levonorgestrel perde eficácia → preferir **DIU de cobre** ou ulipristal.

E depois da pílula? Iniciar um método regular + preservativo.

*Ulipristal: pouco disponível no Brasil e não ofertado no SUS.

DIU como CE: quando NÃO colocar?

🚫 Contraindicações

- Gravidez confirmada ou suspeita (relação anterior);
- IST/DIP ativa (cervicite purulenta, clamídia, gonorreia);
- Sangramento vaginal sem explicação;
- Cavidade uterina distorcida (malformações, miomas submucosos);
- Câncer de colo ou de endométrio; doença trofoblástica;
- Alergia ao cobre ou doença de Wilson.

✅ NÃO são contraindicações

- **Nunca ter tido filhos** (nuliparidade);
- **Adolescência** — DIU é seguro em jovens;
- Ter usado **CE antes** no mesmo ciclo;
- IMC elevado ou uso de anticonvulsivantes (o DIU não depende de hormônio).

⚠️ **Violência sexual:** a norma técnica do Ministério da Saúde prioriza o **levonorgestrel**, pelo risco de IST na inserção do DIU nesse contexto.

Fonte: OMS – Critérios Médicos de Elegibilidade (2015); Ministério da Saúde – Norma Técnica de Violência Sexual (2012).

Aspectos clínicos da CE

1 Sem burocracia

Para a pílula, **não precisa** de exame físico nem de teste de gravidez: basta a história clínica.

2 Pode repetir?

Sim, até no mesmo ciclo — é segura. Mas não substitui um método regular (menos eficaz e desregula o ciclo).

3 Depois do LNG

Iniciar ou retomar o método regular **no mesmo dia** + preservativo por 7 dias.

4 Depois do ulipristal

Esperar **5 dias** para começar hormônio (o progestágeno "anula" o UPA) e usar barreira.

5 Menstruação

Pode adiantar ou atrasar. Atraso > 7 dias → fazer teste de gravidez.

6 E as ISTs?

CE **não protege** contra IST. Avaliar risco, orientar preservativo e, se indicado, PEP.

Fonte: OMS (2021); FSRH – Emergency Contraception Guideline (2023); FEBRASGO.

Aspectos éticos e legais da CE

⚖ Autonomia

É vedado ao médico desrespeitar o direito da paciente de **decidir livremente** sobre o método contraceptivo — e ele deve esclarecer riscos e benefícios.

Código de Ética Médica, art. 42 · Lei 9.263/96

🔒 Adolescentes

Têm direito a atendimento e **sigilo**, sem obrigatoriedade dos pais. Exceção: menor de 14 anos = estupro de vulnerável → notificar e acionar o Conselho Tutelar.

ECA · CEM, art. 74 · Código Penal, art. 217-A

🛡 Violência sexual

Atendimento **imediato e integral**, incluindo a prevenção da gravidez. Não exige boletim de ocorrência. Notificação compulsória.

Lei 12.845/2013 (Lei do Minuto Seguinte) · Lei 10.778/2003

🤝 Objeção de consciência

O médico pode recusar por convicção, mas **deve garantir o encaminhamento** — e não pode recusar em urgência ou sem outro profissional. Lembrar: **CE não é aborto**.

Código de Ética Médica, cap. I (VII) e cap. II (IX)

Mito ou Verdade?

1. Quem nunca teve filhos não pode usar DIU. ?

2. O DIU de cobre é a CE mais eficaz. ?

3. Adolescente só recebe CE acompanhada dos pais. ?

4. Vítima de violência sexual precisa de B.O. para receber a CE. ?

5. A contracepção de emergência protege contra ISTs. ?

6. O DIU colocado como CE pode ficar por até 10 anos. ?

Levante a mão quem acha que é MITO 🙋

Mito ou Verdade?

1. Quem nunca teve filhos não pode usar DIU.
Nuliparidade não é contraindicação.

MITO

2. O DIU de cobre é a CE mais eficaz.
> 99%, até 120 h, sem efeito do IMC.

VERDADE

3. Adolescente só recebe CE acompanhada dos pais.
Direito a atendimento e sigilo (ECA / CEM).

MITO

4. Vítima de violência sexual precisa de B.O. para receber a CE.
Lei 12.845/2013: atendimento sem B.O.

MITO

5. A contracepção de emergência protege contra ISTs.
Só previne gravidez → preservativo / PEP.

MITO

6. O DIU colocado como CE pode ficar por até 10 anos.
Vira o método contraceptivo regular.

VERDADE